

《黄帝内经针灸学》学习笔记

谢家树博士（香港）

2026-07-04

目录

缘起	5
1 自序	7
2 概论	11
引言	11
2.1 道	13
2.2 人体构架模型	13
2.3 病因论	13
2.4 平人标准	13
2.5 经脉病-藏府病证治法轨	13
2.6 总结	13
3 诊断学	15
引言	15
3.1 望诊	15
3.2 切诊	15

4	目录
4	治疗学 17
引言	18
4.1 治神	18
4.2 调气	18
4.3 调形	18
5	针法 19
引言	20
5.1 九针概说	20
5.2 针功基础	20
5.3 针法枢要	20
自跋	21
学习经典行稳致远	21

缘起

广州卫生职业技术学院的黄偉萍老师推荐在下参加田大哲先生的 5 天讲座，共 10 小时。讲座第 1 天在 2022 年 11 月 18 日。讲座是关于他的书《黄帝内经针灸学》。

黄偉萍老师是在下的老师。

田大哲先生是沧州市执业中医师，是“西北针”郑魁山教授的弟子。2011 年 2 月 1 日，出版《郑魁山针法传心录》一书（ISBN: 9787117139090。人民卫生出版社）。他深入研究《黄帝内经》20 余载，深谙《黄帝内经》古典针法。2021 年 12 月出版《黄帝内经针灸学》一书（ISBN: 9787507763133，出版社：学苑出版社。）

田大哲先生的论文有：

1. 田大哲，赵泾屹，李乃奇。恢刺探微 [J]。中国针灸，2021，41(01):41-43.DOI:10.13703/j.0255-2930.20191205-k0007。
2. 田大哲，白英哲，李乃奇。Case for non-specific pain on waist of a pregnant woman[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion, 2019, 29(04):322-324。
3. 田大哲，赵泾屹，李乃奇。偶刺发微 [J]。中国针灸，2019，39(10):1115-1116。DOI:10.13703/j.0255-2930.2019.10.023。
4. 田大哲，李乃奇，翟军。平补平泻论 [J]。中国针灸，2019，39(05):497-500。DOI:10.13703/j.0255-2930.2019.05.010。
5. 田大哲，赵泾屹，李乃奇。营卫补泻探微 [J]。新中医，2018，50(10):229-231。DOI:10.13457/j.cnki.jncm.2018.10.068。

6. 田大哲。复兴中医的关键在于还原中医 [C]。2009 上海·第三届扶阳论坛暨扶阳学派理论与临床应用培训班论文集, 2009:94-96。
7. 田大哲, 刘骏驰, 赵娟, 郑俊江。民族脊梁针法慈航——记新中国针灸事业的奠基者郑毓琳先生 [J]。中国针灸, 2007(07):545-548。
8. 杜广一, 田大哲。中西医结合治疗脑梗死 168 例 [J]。中国民间疗法, 2007(03):9-10。DOI:10.19621/j.cnki.11-3555/r.2007.03.008。
9. 方晓丽, 田大哲, 李金田, 郑俊江。针坛魁斗照河山——记当代中国针灸针法研究之父郑魁山教授 [J]。中国针灸, 2007(02):141-146。
10. 鄢丽, 田大哲。刘春龙应用小柴胡汤举隅 [J]。中国社区医师 (综合版), 2006(09):58-59。
11. 田大哲。肛门内口血泡案 [J]。中国针灸, 2006(01):26。
12. 田大哲。泄泻治验 [J]。河北中医, 2005(03):176。
13. 田大哲。挑治法治疗“翻欺”证 1 例 [J]。河北中医, 2004(06):414。

以下是在下自学的笔记。课本是《黄帝内经针灸学》。

笔记内容是按该书的目录排版。

Chapter 1

自序

中医典籍有四大经典，分别是《黄帝内经》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》。《黄帝内经》乃中医四大经典之首。

《黄帝内经》分为《灵枢》和《素问》2部分，共 15 万字经文。《灵枢》是黄帝内经针灸学诊疗体系与针法体系的主体，《素问》则是对其基础理论的阐述与充实。两者主要文体形式是「师徒问对」，是未经整理过的课堂笔记，属于先秦古文“语录体”范畴。

田大哲解构《黄帝内经》成为《黄帝内经针灸学》一书。

什么是解构一部书籍？就是把它全部章节先行分拆，再行重构，并在重构中，展现文本原有的意义、内涵与逻辑。这就要找到了书眼。

为什么要解构《黄帝内经》？《黄帝内经》展现的章节凌乱，针灸治疗过程环节条理难辨，这些环节包含诊断、治疗、针法操作等。

《黄帝内经》的书眼就是“虚实”。“阴阳”界定事物的本质，“虚实”分辨“阴阳”的状态，“虚实”是阴阳失衡之内在结果，“寒热”表达的阴阳的偏倾现象，“表里”体现的是阴阳的相对位置，针法的主要作用是补虚写实，故要“先别阴阳”之下的虚实。《黄帝内经》主张的针灸治病的意义，在于从根本上解决一个人的“虚实状态”，其所关注的重点是“证型”，而非单纯地去改变一个人的具体“症候”。于是，“虚实”也便自然而然地成了整部《黄帝内经》的书眼。

治疗疾病时，要分辨经脉病、藏府病、杂病等。这里举的例子，假设只是藏府

病，所以先辨病处的阴阳，即「藏病」还是「府病」，而后再辨其「盛」、「虚」。无论是「藏病」还是「府病」，其常证皆有四种，即阴虚、阴盛、阳虚、阳盛。以下会以肾病为例。但首先介绍一些概念。这些概念会在以后第二章的「输穴」说明。

为了方便理解阴阳经脉的特性，把十二经脉中，相对多气的阳经称为“阳经”，相对多血的阴经称为“阴脉”。

在古圣心目中最关键的输穴，当属「本输」，它们是肘膝而下与五藏六府内外交通能量的根源。阴脉的，统称为五输，即井、荥、输、经、合。阳经的，统称为六输，即井、荥、输、原、经、合。

本输之中，又以「原」为首要，包括阴脉五输之「输」（以「输」为「原」）与阳经六输之「原」。

basis:

《灵枢经·邪气藏府病形 27 - 30》:

黄帝曰：荥俞与合，各有名乎？歧伯答曰：荥俞治外经，合治内府。

黄帝曰：治内府奈何？歧伯曰：取之于合。

黄帝曰：合各有名乎？歧伯答曰：胃合于三里，大肠合入于巨虚上廉，小肠合入于巨虚下廉，三焦合入于委阳，膀胱合入于委中央，胆合入于阳陵泉。

黄帝曰：取之奈何？歧伯答曰：取之三里者，低跗取之；巨虚者，举足取之；委阳者，屈伸而索之；委中者，屈而取之；阳陵泉者，正竖膝予之齐下，至委阳之阳取之；取诸外经者，掄申而从之。

《灵枢经·寿夭刚柔 1 - 2》:

黄帝问于少师曰：余闻人之生也，有刚有柔，有弱有强，有短有长，有阴有阳，愿闻其方。

少师答曰：阴中有阴，阳中有阳，审知阴阳，刺之有方。得病所始，刺之有理。谨度病端，与时相应。内合于五藏六府，外合于筋骨皮肤。是故内有阴阳，外亦有阴阳。在内者，五藏为阴，六府为阳，在外者，筋骨为阴，皮肤为阳。故曰，病在阴之阴者，刺阴之荥俞，病在阳之阳者，刺阳之合，病在阳之阴者，刺阴之经，病在阴之阳者，刺络脉。……

阴脉五输如下：

	井穴	荥穴	输穴	经穴	合穴
手太阴肺经	少商	鱼际	太渊	经渠	尺泽
足太阴脾经	隐白	大都	太白	商丘	阴陵泉
手少阴心经	少冲	少府	神门	灵道	少海
足少阴肾经	涌泉	然谷	太溪	复溜	阴谷
手厥阴心包经	中冲	劳宫	大陵	间使	曲泽
足厥阴肝经	大敦	行间	太冲	中封	曲泉

阳经六输如下：

	井穴	荥穴	输穴	原穴	经穴	合穴
手阳明大肠经	商阳	二间	三间	合谷	阳溪	曲池
足阳明胃经	厉兑	内庭	陷谷	冲阳	解溪	足三里
手太阳小肠经	少泽	前谷	后溪	腕骨	阳谷	小海
足太阳膀胱经	至阴	足通谷	束骨	京骨	昆仑	委中
手少阳三焦经	关冲	液门	中渚	阳池	支沟	天井
足少阳胆经	足窍阴	侠溪	足临泣	丘墟	阳辅	阳陵泉

以肾病为例，肾为藏，属阴，而其又分阴阳，又再分虚、盛，即肾阴虚、肾阴盛、肾阳虚、肾阳盛。

肾阴（“病在阴（肾）之阴”）有盛虚，“病在阴之阴”，其治当取“阴之荥、输”，即肾之“荥、输”，即然谷、太溪，阴虚者补之，阴盛者泻之。

肾阳（“病在阴（肾）之阳”）有盛虚，病在阴之阳，取本经脉之“井穴”涌泉，肾阳虚者补涌泉，肾阳盛者泻涌泉。除了刺涌泉补泻外，还可取相表里膀胱经之“原穴”京骨，或/及“经穴”昆仑，亦可以取肾输。肾阳虚者补之，肾阳盛者泻之。

need to explain basis ···

至此，藏府证治法轨已然定形，而阳经设本输之要义亦彰明昭着，是为五藏之“阳输”，尤以“原”为要，其与五藏本输之“原”共同成了调治五藏阴阳之虚实偏的主要靶点，这是古圣“以五藏为中心”思想的具体表现。笔者别输穴之构想虽然肤浅，但能以此出人意料之完美结果收官，亦足可慰矣。由此而总结出的“藏府病证治法轨”，使五藏六府之疾的治疗皆具有了靶向性，其与“经脉病证治法轨”共同构建了黄帝内经针灸学证治的钢筋铁骨。证治法轨与补虚泻实针法契合自然，与诊断学亦保持了高度的自治性，是知其当有大用。

经历多次类似上述启迪而重构的黄帝内经针灸学，最终定稿为“概论”“诊断学”“治疗学”“针法”等四章。其中，概论部分为黄帝内经针灸学之核心思想总括；诊断学部分，辨证皆循辨阴阳虚实之法，经脉病需要辨阴阳之虚实，藏府病需要辨阴阳之虚实，杂病亦然，其辨虚实之法又皆以神、气、色、形分别辨之；治疗学部分，治疗皆循调阴阳盛虚之法，经脉病、藏府病、杂病等又皆统摄于治神、调气、调形三类之中，虚则补之，实则泻之，乱则调之；针法部分，包括治神针法、调气针法、调形针法，分而述之，是为《黄帝内经》辨证施治之决胜环节。

Chapter 2

概论

引言

诊疗是辨阴阳的盛虚、调阴阳之盛虚。针法是选任相应输穴而实现补虚实。

在操针过程中遵循“盛者泻之，虚者补之，乱者调之”之法，令不平之气复归于平，是为《黄帝内经》之道。

2.1 道

2.2 人体构架模型

2.2.1 阴阳

2.2.2 形气

2.2.3 营卫

2.2.4 藏府-经脉

2.2.5 藏府

2.2.6 经脉

2.2.7 输穴

2.3 病因论

2.3.1 内因

2.3.2 外因

2.4 平人标准

2.4.1 脉象之“平”

2.4.2 气机之“平”

2.4.3 形气之“平”

2.4.4 神态之“平”

2.5 经脉病-藏府病证治法轨

2.5.1 病在经脉者

2.5.2 病在藏府者

2.5.3 小结

Chapter 3

诊断学

引言

3.1 望诊

3.1.1 望诊四要

3.1.2 望诊之法

3.2 切诊

3.2.1 切经脉

3.2.2 切体

Chapter 4

治疗学

引言

4.1 治神

4.1.1 以神治神

4.1.2 以气全神

4.1.3 以形调神

4.1.4 失眠、癫狂之诊疗

4.2 调气

4.2.1 去邪胜

4.2.2 调经脉

4.2.3 调藏府

4.2.4 调杂病

4.3 调形

4.3.1 皮

4.3.2 肉

Chapter 5

针法

引言

5.1 九针概说

5.1.1 鑱针

5.1.2 员针

5.1.3 鍤针

5.1.4 锋

5.1.5 铍针

5.1.6 员利针

5.1.7 毫针

5.1.8 长针

5.1.9 大针

5.2 针功基础

5.2.1 持针之道

5.2.2 练针大法

自跋

学习经典行稳致远